Pack stage IFSI (constantes, échelles, transmissions, précautions)

Repères de l'adulte pour le stage : constantes, échelles, transmissions, hygiène et AES

Clairance

Sommaire

1 Constantes de l'adulte....1
2 Échelles de la douleur....1
3 Score de Glasgow....1
4 Risque d'escarre : échelle de Braden....2
5 Transmissions....2
6 Précautions standard....3
7 Précautions complémentaires....3
8 Accident d'exposition au sang (AES)....3

Référentiel 2026 (arrêté du 20 février 2026, entrant.e.s à partir de septembre 2026) : gestes évalués en stage ou en pratique simulée dans l'UE B.3 « Pratiques et interventions infirmières » (S1, S2).
Repères de l'adulte. Les valeurs, seuils et conduites du protocole de votre service priment.

1 Constantes de l'adulte

Paramètre	Repère	Unité
Fréquence cardiaque (repos)	60 à 100	/min
Pression artérielle (consultation)	HTA si ≥ 140/90	mmHg
Pression artérielle (automesure)	HTA si ≥ 135/85	mmHg
Fréquence respiratoire (repos)	12 à 20	/min
SpO_2 (air ambiant)	≥ 95	%
Température	36,5 à 37,5	°C

NOTE CLINIQUE Valeur anormale ou inhabituelle
Recontrôler la mesure (matériel, position, repos), comparer aux valeurs précédentes du.de la patient.e et à l'état clinique, puis **alerter sans attendre** l'infirmier.e référent.e ou le.la médecin selon le protocole du service. Le recontrôle ne retarde jamais l'alerte devant un.e patient.e qui se dégrade.

PIÈGE
Un chiffre « normal » ne rassure pas seul : la tendance (valeurs successives) et l'aspect du.de la patient.e comptent autant. Une cible prescrite pour ce.tte patient.e (SpO_2 notamment) passe avant le repère du tableau.

2 Échelles de la douleur

Échelle	Cotation et seuil de prise en charge (indicateur HAS)
EVA	Auto-évaluation. Réglette de 0 à 10 cm (0 à 100 mm). Prise en charge si ≥ 4/10 (≥ 40/100).
EN	Auto-évaluation. Note de 0 à 10 donnée par le.la patient.e. Même seuil que l'EVA.
EVS	Auto-évaluation (échelle verbale simple). De 0 (absente) à 4 (extrêmement intense) : absente, faible, modérée, intense, extrêmement intense. Prise en charge si ≥ 2.
Algoplus	Hétéro-évaluation, personne âgée qui ne peut pas s'auto-évaluer. Score de 0 à 5. Prise en charge si ≥ 2.

Ces seuils sont ceux de l'indicateur de qualité : toute douleur exprimée se trace et se réévalue ; la conduite est celle du protocole du service.

PIÈGE
Choisir **une** échelle et la garder pour suivre l'évolution : un score d'EVA et un score d'EN ne se comparent pas d'une prise à l'autre. Tracer l'échelle utilisée avec le score.

3 Score de Glasgow

Item	Points	Meilleure réponse obtenue
	4	Ouverture spontanée

Item	Points	Meilleure réponse obtenue
Yeux (Y)	3	À la demande ou au bruit
	2	À la douleur
	1	Aucune
Verbal (V)	5	Orientée
	4	Confuse
	3	Mots inappropriés
	2	Sons incompréhensibles
	1	Aucune
Moteur (M)	6	Obéit aux ordres
	5	Localise la douleur
	4	Évitement (retrait)
	3	Flexion stéréotypée (décortication)
	2	Extension stéréotypée (décérébration)
	1	Aucune

Score = Y + V + M, de 3 à 15. Noter le détail des trois items, pas seulement le total.

EXEMPLE Calcul du score
Yeux à la demande (3), réponse confuse (4), localise la douleur (5) : 3 + 4 + 5 = 12, à noter Y3 V4 M5.

NOTE CLINIQUE Baisse du score
Toute baisse par rapport à la cotation précédente s'alerte immédiatement, selon le protocole du service.

4 Risque d'escarre : échelle de Braden

Item	Cotation
Perception sensorielle	1 à 4
Humidité	1 à 4
Activité	1 à 4
Mobilité	1 à 4
Nutrition	1 à 4
Friction et cisaillement	1 à 3

Score total de 6 à 23 : **plus le score est bas, plus le risque est élevé**. Le seuil qui déclenche les mesures de prévention est celui du protocole du service.

5 Transmissions

Transmissions ciblées

- **Cible** : ce qui pose problème ou change (symptôme, réaction, événement), en quelques mots.
- **D, données** : faits observés et mesurés, propos du.de la patient.e.
- **A, actions** : ce qui a été fait, et par qui.
- **R, résultats** : effet observé, réévalué à l'heure dite.

SAED (adaptation française de SBAR, HAS)

- **S, situation** : qui j'appelle, pour quel.le patient.e, motif de l'appel, constantes.
- **A, antécédents** : contexte, traitements, allergies, évolution récente.
- **E, évaluation** : ce que j'en pense, ce qui m'inquiète.
- **D, demande** : ce que j'attends, dans quel délai ; puis reformuler la décision.

NOTE CLINIQUE Traçabilité
Écrire ce qui est fait, quand il est fait : date, heure, identification de l'auteur.rice. Chaque administration est tracée sur le même support que la prescription. Faits objectifs, sans jugement ; jamais d'acte tracé à l'avance.

6 Précautions standard

Champ (SF2H)
Pour tout soin, en tout lieu, pour tout.e patient.e, quel que soit son statut infectieux.

Les 5 indications de l'hygiène des mains (OMS)

1. Avant de toucher un.e patient.e.
2. Avant un geste aseptique.
3. Après un risque d'exposition à un liquide biologique.
4. Après avoir touché un.e patient.e.
5. Après avoir touché l'environnement du.de la patient.e.

Mesure	Repère
Mains	Friction hydro-alcoolique : technique de référence, gants ou non.
Gants	Si risque de contact avec du sang, un liquide biologique, une muqueuse ou une peau lésée ; pas de gants pour un contact avec une peau saine.
Masque, lunettes	Masque à usage médical (au minimum de type I, norme EN 14683) et lunettes si risque de projection ; masque pour le.la patient.e qui tousse.
Matériel	Matériel de sécurité et à usage unique ; conduite AES connue de tous.

7 Précautions complémentaires

Type	Mesures (en plus des précautions standard)
Air	Chambre individuelle, porte fermée. Appareil de protection respiratoire FFP2 mis **avant** d'entrer, même chambre vide ; étanchéité vérifiée (fit check) à chaque port. Masque chirurgical pour le.la patient.e qui sort de sa chambre.
Gouttelettes	Masque chirurgical pour le.la soignant.e dès l'entrée ; masque chirurgical pour le.la patient.e qui sort de sa chambre.
Contact	Hygiène des mains renforcée ; protection de la tenue (tablier) pour les soins au contact du.de la patient.e ou de son environnement.

⚠ PIÈGE
La signalétique sur la porte et le protocole du service indiquent le type de précautions : ne pas le déduire du diagnostic supposé.

8 Accident d'exposition au sang (AES)

Premiers soins, tout de suite (INRS)

Piqûre, coupure, peau lésée : ne pas faire saigner ; nettoyer à l'eau et au savon, rincer ; désinfecter au moins 5 min (Dakin, ou eau de Javel à 2,6 % de chlore actif diluée au 1/5e ; à défaut polyvidone iodée en solution dermique ou alcool à 70°).
Projection sur une muqueuse (œil, bouche, nez) : rincer abondamment au moins 5 min au sérum physiologique ou à l'eau.

✚ NOTE CLINIQUE Délais
Dans l'heure : avis médical, selon la procédure AES de l'établissement, pour évaluer le risque infectieux ; un traitement post-exposition, s'il est indiqué, débute idéalement dans les 4 h.
Dans les 24 h : informer sa hiérarchie (en stage : le service et l'IFSI), déclarer l'accident du travail, suivre les recommandations médicales, informer le.la médecin du travail.

⚠ PIÈGE
Ne pas attendre la fin du soin ou du poste pour consulter : le délai compte à partir de l'accident.

Sources : HAS (HTA de l'adulte, indicateur douleur IQSS, guide SAED), SF2H (précautions standard ; transmission par voie respiratoire), OMS (5 indications de l'hygiène des mains), INRS (affiche AES « En urgence : premiers soins à faire »), AP-HP (dossier de soins), CHUV (score de Glasgow), HUG (échelle de Braden), arrêtés relatifs au diplôme d'État d'infirmier ; détail dans les références du produit.